

아쿠아블레이션(물분사 절제술) (전립선 물분사 수술)

WARWIKI

환자 안내문 · 열을 사용하지 않는 영상 유도 전립선비대 치료

아쿠아블레이션(물분사 절제술)은 전립선비대증(BPH) 치료를 위한 새로운 수술법입니다. 요도를 통해 삽입한 기구로 열을 사용하지 않는 고압 물줄기를 초음파 영상으로 정밀하게 유도하여 소변 흐름을 막는 조직을 제거합니다. 기존 경요도전립선절제술(TURP)에 비해 역행성 사정이 적게 발생하여 사정 기능 보존에 유리합니다.

이 시술에 대하여

집도의는 내시경과 실시간 초음파 영상으로 전립선을 확인한 뒤 제거할 조직 범위를 계획합니다. 이후 로봇이 제어하는 고압 물줄기가 열 없이 해당 조직을 정밀하게 제거합니다. 짧은 지혈 처치 후 도뇨관을 삽입합니다.

아쿠아블레이션의 장점

- 영상 유도로 정밀하며, 큰 전립선을 포함한 다양한 크기에 적용 가능
- 소변 흐름 개선 효과가 TURP와 동등
- TURP보다 사정 기능 보존에 유리한 설계

비교적 새로운 시술로, 장기 추적 데이터는 아직 축적 중입니다.

용어 설명

아쿠아블레이션(물분사 절제술)

BPH 치료를 위해 고압 물줄기로 전립선 조직을 제거하는 시술.

전립선비대증(BPH)

양성(비암성) 전립선 비대.

열을 사용하지 않는

조직 제거에 열 대신 수압을 이용함.

초음파 유도

실시간 영상으로 치료 범위를 정밀하게 계획.

역행성 사정

사정 시 정액이 역류하는 현상 — TURP보다 발생률이 낮음.

도뇨관

수술 후 하루 이틀 동안 방광을 비우는 관.

TURP와 무엇이 다른가요? 전기 루프 대신 **초음파 유도 하에 열을 사용하지 않는 정밀 고압 물줄기로** 전립선 조직을 제거합니다. 소변 흐름 개선 효과는 TURP와 유사하지만 **사정 기능 보존** 가능성이 더 높습니다. 새로운 기술이라 장기 데이터가 적고, 출혈은 짧은 지혈 처치로 관리합니다.

준비 방법

- **전신마취 또는 척추마취**로 진행되므로 금식과 약물 복용 지침을 따르세요 (혈액 희석제는 지시에 따라 중단).
- 감염 여부 확인을 위해 **소변 검사**를 실시합니다.
- 귀가 차량을 미리 마련하고, 도뇨관 착용 기간을 고려하여 일정을 조정하세요.

시술 과정 및 회복

- 1 마취로 통증 없이 진행되며, 항생제를 투여합니다.
- 2 초음파로 전립선을 확인하고 치료 범위를 계획합니다.
- 3 고압 물줄기로 조직을 제거하고 짧은 지혈 처치를 합니다.
- 4 도뇨관을 삽입하며, 보통 **1-2일** 후 제거합니다. 대부분 하룻밤 입원합니다.

수주 동안 **혈뇨**와 배뇨 시 약한 작열감·절박뇨가 있을 수 있습니다. 수분을 충분히 섭취하고 무거운 물건 들기와 힘주기를 피하세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 도뇨관 제거 후 **소변이 전혀 나오지 않을 때**
- **심한 출혈이나 혈괴**로 소변이 막힐 때
- 발열 또는 오한이 있을 때
- 출혈이 나아지지 않고 악화될 때

기억할 세 가지

1. **아쿠아블레이션(물분사 절제술)**은 초음파 유도 하에 열을 사용하지 않는 정밀 고압 물줄기로 요도를 통해 전립선 폐색 조직을 제거합니다.
2. 소변 흐름 개선 효과는 TURP와 동등하며 **사정 기능 보존** 가능성이 더 높습니다. 새로운 기술이라 장기 데이터는 축적 중입니다.
3. 도뇨관 착용 기간은 짧습니다. 배뇨 불가, 심한 출혈, 발열이 있으면 즉시 연락하세요.